

Dismenorrea

1. Introducción y relevancia clínica

La **dismenorrea** se define como el **dolor pélvico tipo cólico asociado a la menstruación**, de intensidad suficiente para interferir con las actividades cotidianas.

Es una de las **causas más comunes de ausentismo escolar y laboral** en mujeres jóvenes y una de las consultas ginecológicas más frecuentes en atención primaria.

Existen dos formas:

- **Dismenorrea primaria:** dolor menstrual sin patología pélvica estructural.
- **Dismenorrea secundaria:** dolor menstrual asociado a una causa orgánica (endometriosis, adenomiosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, etc.).

La distinción entre ambas es esencial, ya que la primera es **benigna y funcional**, mientras que la segunda puede ser un **signo de enfermedad ginecológica subyacente**.

□ En EUNACOM: es típico que se pregunte la **diferencia entre dismenorrea primaria y secundaria**, el **mecanismo fisiopatológico de la primaria (prostaglandinas)**, y el **manejo inicial recomendado (AINES + ACO combinados)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Dismenorrea primaria

- Ocurre en mujeres jóvenes (menores de 25 años) con **ovulaciones regulares y anatomía pélvica normal**.
- Se debe a un aumento de la **producción de prostaglandinas ($\text{PGF}_2\alpha$ y PGE_2)** en el endometrio durante la menstruación.
- Estas prostaglandinas causan:
 - **Hipercontractilidad uterina.**
 - **Isquemia miometrial.**

- **Sensibilización nerviosa periférica y central.**

El pico de prostaglandinas coincide con el inicio del sangrado menstrual, explicando la cronología del dolor.

b. Dismenorrea secundaria

- Aparece habitualmente en mujeres de mayor edad (>25–30 años) y suele **aumentar progresivamente con el tiempo**.
- El dolor se relaciona con una **patología pélvica identificable**, como:
 - **Endometriosis** (causa más frecuente).
 - **Adenomiosis**.
 - **Miomas uterinos submucosos**.
 - **Enfermedad inflamatoria pélvica crónica**.
 - **Dispositivos intrauterinos de cobre**.

El dolor puede acompañarse de dispareunia, infertilidad, metrorragia o síntomas gastrointestinales.

3. Clínica: características diferenciales

Característica	Dismenorrea primaria	Dismenorrea secundaria
Edad de inicio	Adolescencia (1–2 años post menarquia)	>25 años o tras años de menstruaciones indoloras
Ciclos	Regulares y ovulatorios	A menudo irregulares
Inicio del dolor	1 día antes o con la menstruación	Días previos o persistente

Duración	24–72 horas	>3 días, puede extenderse
Intensidad	Cíclica, tipo cólico	Progresiva, constante
Irradiación	Lumbosacra, muslos	Variable según causa
Síntomas asociados	Náuseas, vómitos, cefalea, diarrea	Dispareunia, metrorragia, infertilidad
Examen físico	Normal	Alterado según patología (masa, dolor anexial, útero aumentado)

□ En EUNACOM: “Dolor pélvico cíclico en adolescente con examen ginecológico normal → dismenorrea primaria.”

4. Diagnóstico

a.

Diagnóstico clínico

- **Primaria:** se basa en la historia típica en adolescente o mujer joven con examen ginecológico normal.
- **Secundaria:** se sospecha ante:
 - Dolor progresivo o resistente al tratamiento.
 - Aparición tardía del dolor.
 - Síntomas asociados (infertilidad, dispareunia, metrorragia).
 - Alteraciones en el examen ginecológico.

b.

Examen físico

- En dismenorrea primaria: **sin hallazgos.**
- En dismenorrea secundaria: puede hallarse:
 - Útero aumentado (adenomiosis, miomas).
 - Dolor a la movilización cervical (EIP).
 - Nódulos o sensibilidad anexial (endometriosis).

c.

Exámenes complementarios

- No se requieren en la dismenorrea primaria típica.
 - En dismenorrea secundaria:
 - **Ecografía transvaginal:** primer examen (miomas, adenomiosis, quistes, endometriomas).
 - **RM pélvica:** útil en casos complejos o sospecha de endometriosis profunda.
 - **Laparoscopia diagnóstica:** estándar de oro para endometriosis.
-

5. Tratamiento

a.

Dismenorrea primaria

1. Medidas generales

- Ejercicio regular.
- Calor local.
- Manejo del estrés y del sueño.

2. Fármacos de primera línea

- **AINEs (antiinflamatorios no esteroideos):** inhiben la síntesis de prostaglandinas.
 - Ejemplo: ibuprofeno, naproxeno, mefenámico, ketoprofeno.
 - Deben iniciarse **1–2 días antes de la menstruación** y mantenerse por 2–3 días.

3. Anticonceptivos hormonales combinados (ACO)

- Suprimen la ovulación y reducen la producción endometrial de prostaglandinas.
- Útiles en pacientes con mala respuesta a AINEs o deseo anticonceptivo.

4. Alternativas

- Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU-Mirena).
- Acetato de medroxiprogesterona inyectable.
- Inhibidores de COX-2 (celecoxib).

En EUNACOM: “Primera línea para dismenorrea primaria: AINEs; segunda línea: anticonceptivos hormonales combinados.”

b.

Dismenorrea secundaria

El tratamiento depende de la causa:

Etiología	Tratamiento
Endometriosis	ACO, progestinas, análogos de GnRH, cirugía laparoscópica.
Adenomiosis	ACO continuos, DIU-LNG, histerectomía si no desea fertilidad.

Miomas submucosos	Miomectomía o histeroscopia.
--------------------------	------------------------------

EIP crónica	Antibióticos + control de pareja.
--------------------	-----------------------------------

DIU de cobre	Retiro si se asocia a dolor.
---------------------	------------------------------

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Complicación	Pronóstico
Primaria	Ausentismo escolar/laboral, impacto emocional	Excelente con tratamiento
Secundaria (endometriosis, adenomiosis)	Infertilidad, dolor crónico	Variable, puede requerir cirugía
Dolor pélvico crónico	Afectación de calidad de vida	Requiere manejo multidisciplinario

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dismenorrea primaria** → por prostaglandinas, sin patología pélvica.
2. **Dismenorrea secundaria** → por enfermedad pélvica estructural (endometriosis, adenomiosis).

3. **AINEs** son el tratamiento inicial de elección.
4. **ACO combinados** son segunda línea y útiles en manejo conjunto.
5. **Dolor progresivo, dispareunia o metrorragia** → sospechar causa secundaria.
6. **Ecografía transvaginal** es el examen inicial en dismenorrea secundaria.
7. **Endometriosis** es la causa más frecuente de dismenorrea secundaria en mujeres jóvenes.



Errores comunes

- Indicar AINEs solo al iniciar el dolor (deben iniciarse antes).
- No investigar causas secundarias en dolor progresivo.
- Confundir dismenorrea con dolor pélvico crónico.
- Omitir anticonceptivos como opción terapéutica.
- No ofrecer manejo integral (educación, contención, hábitos saludables).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Dismenorrea:** dolor menstrual tipo cólico que interfiere con la vida diaria.
2. **Primaria:** funcional, por exceso de prostaglandinas; **secundaria:** por patología pélvica.
3. **AINEs** son el tratamiento de elección; **ACO** suprimen ovulación y reducen dolor.
4. **Endometriosis** es la causa más común de dismenorrea secundaria.
5. **Ecografía transvaginal** es el estudio inicial ante sospecha secundaria.
6. Dolor que **aparece años después de la menarquia** o **progresivo** → descartar patología.
7. Pronóstico excelente si se trata oportunamente y se maneja de forma integral.

